Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Crissiumal

Rua Vinte de Setembro, 245 - Bairro: Centro - CEP: 98640000 - Fone: (55) 3029-9956 - Balcão Virtual: (55) 9.9727-0132 - Email: frcrissiumvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000991-98.2024.8.21.0094/RS

AUTOR: MARIA LURDES KONRATH RUVER

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

MARIA LURDES KONRATH RUVER ajuizou ação de obrigação de fazer, c/c tutela antecipada, em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**.

Narrou, em síntese, ser segurada do plano de saúde IPE SAÚDE, com carteira nacional de saúde n.° 73.02076152.04.3. Disse pagar corretamente as mensalidades, estando em dia com sua obrigação e com contrato de plano de saúde ativo há mais de 20 anos. Manifestou ser pessoa idosa, com idade superior a 80 anos, acometida pelas patologias de diabete mellitus - insiluno dependente (CID10 E10.1), hipertensão (CID10 I10) e arritmia cardíaca (CID10 I49), fazendo uso de medicação contínua. Aduziu necessitar de cuidados técnicos de enfermagem, com assistência diária para auxiliar nas atividades de vida diária, como higiene pessoal, troca de curativos e administração de medicamentos. Da mesma forma, disse fazer-se necessária assistência médica mediante visitas regulares, a cada 15 dias, para monitorar sua saúde, administrar e prescrever medicamentos e realizados procedimentos necessários; assim como suporte psicossocial, com acesso a profissional de saúde mental e psicológico uma vez por semana, para fins de lhe fornecer o apoio emocional necessário. Relatou necessitar de sessões de acompanhamento com fisioterapia duas vezes na semana, para promover a reabilitação, melhora na mobilidade e proporcionar maior independência para a paciente. Suscitou ter buscado a ré visando tratamento médico adequado (*home care*), no entanto, o plano de saúde negou o tratamento à autora. Liminarmente, requereu a prestação dos serviços médicos na modalidade *home care*. Postulou a procedência do pedido, para fins de confirmar a tutela de urgência, condenando a parte ré à obrigação de fornecer o serviço de *home care* de forma permanente, enquanto perdurar a necessidade. Pugnou a concessão da gratuidade judiciária. Juntou documentos.

Determinada a adequação do valor da causa (evento 9.1), o que foi atendido pela autora (evento 12.1).

Deferida a gratuidade judiciária e indeferido o pedido de tutela de urgência (evento 14.1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 24.1). Teceu comentários acerca da necessidade de observância do escopo do tratamento requerido pela autora, fazendo-se necessário diferenciar o atendimento domiciliar entre as modalidades de atenção domiciliar. Disse que os planos de saúde somente estão sujeitos ao fornecimento de atendimento na modalidade internação domiciliar quando efetivamente comprovada a necessidade de substituição da internação hospitalar. Manifestou a dificuldade financeira enfrentada pelo réu, visto que é remunerado com base em um percentual sobre a remuneração de alguns de seus membros e possui quantidade desproporcional de usuários com mais de 59 anos, o que desequilibra gravemente as contas e o cálculo atuarial do plano. Discorreu acerca da inconstitucionalidade da ampliação da cobertura sem indicação da fonte de custeio. Postulou a improcedência da pretensão autoral.

Intimadas para dizer sobre as provas (evento 30.1), a ré requereu a realização de estudo social (evento 35.1), ao passo em que a autora postulou realização de audiência conciliatória e produção de prova oral (evento 36.1).

Deferida a produção de prova oral e a realização de estudo social (evento 38.1).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de dois informantes arrolados pela autora. Na mesma oportunidade, indeferido o pedido de realização de inspeção judicial e declarada encerrada a instrução (evento 67.1).

As partes apresentaram memoriais (eventos 70.1 e 71.1).

Convertido o feito em diligência, oportunizando a manifestação do Ministério Público (evento 74.1).

O Ministério Público apresentou parecer (evento 77.1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Decido.

A pretensão da autora fundamenta-se na prestação do serviço de internação domiciliar (*home care*) por parte da parte ré, por tempo indeterminado, nos termos do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento do quadro clínico da autora, defendendo estar acometida por diabete mellitus - insiluno dependente (CID10 E10.1), hipertensão (CID10 I10) e arritmia cardíaca (CID10 I49), fazendo uso de medicação contínua.

Pois bem. Não há qualquer alegação contrária à existência de vínculo entre as partes, cingindo-se a controvérsia quanto à obrigação ou não de cobertura, por parte do réu, de tratamento multidisciplinar de que necessita a autora. Na relação jurídica existente entre as partes, aplica-se, portanto, o artigo 374, inciso III do CPC.

A atividade de plano de saúde está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se verifica da leitura do artigo 3º, §2º do diploma consumerista, *in verbis:*

> *Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *§1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
>
> *§2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Outrossim, tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ, segundo a qual, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".*

Quanto à organização do IPE-Saúde, assim dispõem os artigos 1º e 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018:

> *Art. 1º Fica reorganizado, na forma desta Lei Complementar, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, denominado Sistema IPE Saúde, tendo como gestor o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPE Saúde -, segundo os ditames da presente Lei Complementar, resoluções e regulamentos próprios.*
>
> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - Sistema IPE Saúde - consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*
>
> *§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.*
>
> *§ 3º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.*

Embora não se desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados.

Neste sentido:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016).*

Tal conduta, baseada em regulamentação administrativa, viola a lei de regência do Instituto e vai de encontro aos princípios constitucionais do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

É o entendimento deste Tribunal:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a concessão de tratamento domiciliar na modalidade home care a beneficiário do plano de saúde gerido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE-Saúde). O agravante, diagnosticado com transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco e outras comorbidades, requereu a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo técnico de enfermagem para acompanhamento contínuo, alegando risco de agravamento do quadro clínico e necessidade de desospitalização com suporte adequado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, bem como a obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar pelo IPE-Saúde. O agravante sustenta que a negativa do plano de saúde viola o direito fundamental à saúde e contraria laudos médicos que indicam a imprescindibilidade do home care para evitar novas internações e complicações graves. O IPE-Saúde argumenta que o serviço requerido não está expressamente previsto em sua cobertura, não havendo obrigação de custeá-lo. III. Razões de decidir: Demonstrada a gravidade do quadro clínico do agravante e a necessidade de atendimento contínuo para garantir a eficácia do tratamento, bem como evitar riscos de deterioração do estado de saúde, conforme indicado nos laudos médicos juntados aos autos. A urgência do tratamento decorre da iminência de agravamento das condições psiquiátricas e físicas do paciente, com possibilidade de eventos fatais e prejuízos irreversíveis caso não receba a assistência adequada. A negativa de cobertura pelo IPE-Saúde não se sustenta, uma vez que os serviços solicitados encontram respaldo na Lei Complementar nº 15.145/2018 e em normativas internas da autarquia, que garantem a prestação de assistência integral aos beneficiários. Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que a assistência domiciliar na forma de home care configura extensão da internação hospitalar e deve ser fornecida quando essencial ao tratamento do paciente. Diante da robustez das provas apresentadas, resta configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, impondo-se a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido para confirmar a tutela de urgência deferida em grau recursal, determinando ao IPE-Saúde a disponibilização do tratamento domiciliar (home care), com a equipe multidisciplinar especificada nos laudos médicos. Tese: É possível o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care quando comprovada sua necessidade mediante laudo médico, sendo indevida a negativa de cobertura pelo IPE Saúde com fundamento na*

ausência de previsão expressa no regulamento do plano. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei Complementar nº 15.145/2018, art. 4º; TJRS, Apelação Cível nº 50009626520208210069, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 27.11.2024. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53575070820248217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18/02/2025).

No caso em tela, a autora requer que a ré forneça, imediatamente, o atendimento domiciliar na modalidade *home care* prescrito pelo médico assistente, com acompanhamento técnico de enfermagem 24 horas/dia, enfermeiro conforme a necessidade ou ao menos uma vez na semana, atendimento psicológico uma vez por semana e fisioterapêutico duas vezes na semana, bem como atendimento médico a cada 15 dias.

Em análise aos autos, verifico que demonstrada a condição de saúde da autora e a respectiva necessidade de receber cuidados e atendimento médico domiciliares, consoante laudos e atestados médicos juntados à exordial e ao longo de toda a marcha processual (eventos 1.6 e 23.2).

Paciente tem idade avançada, com infecções urinárias e gastrointestinais recorrentes, imunidade deprimida devido a idade avançada, e doenças crônicas pré existentes, sendo que o melhor tratamento é o domiciliar com equipe técnica competente, para desenvolver esse trabalho, evitando-se assim internações e infecções hospitalares, o que poderia até mesmo ocasionar a morte da paciente.

Paciente vem involuindo em seu estado geral, com emagrecimento rápido repentino, com fragilidade muscular intensa, o que já a impede de deambular, e permanecer sentada no leito. Verbaliza pouco. Dessa forma solicito rapidez no caso em questão pois trata-se de manter a vida dessa idosa.

O Home Care possibilita a internação domiciliar, no ambiente conhecido do idosos, com envolvimento de familiares no cuidado, proporcionando conforto, humanização no atendimento e cuidados especializados de diversos profissionais da saúde.

Dentro dessa justificativa, solicito rápida ação dos órgãos competentes para evitar a morte da paciente que tem risco maior ainda se internada, devido a imunidade e risco de adquirir infecção hospitalar.

Portanto reitero que o tratamento e acompanhamento em Home Care é o tratamento ideal e mais indicado para a paciente mencionada.

De igual forma, a prova oral produzida em juízo vai ao encontro dos relatos prestados pela autora.

***Jorge Antonio Dornelles**, arrolado pela autora e ouvido na qualidade de informante, relatou que vai à residência da autora pelo menos duas vezes ao dia e, por vezes, também à noite, para auxiliar a cuidadora a retirá-la da cama, levá-la ao banheiro, dar-lhe banho e prestar outros auxílios necessários. Relatou que comparece diariamente à casa da autora para ajudar, pois ela não consegue se locomover sozinha de forma adequada e, em diversas ocasiões, já sofreu quedas. Informou que as dificuldades de locomoção da autora iniciaram há cerca de cinco anos, agravando-se nos últimos dois anos. Confirmou que a autora conta com os cuidados de uma vizinha durante todo o dia e, à noite, é assistida por uma cuidadora que permanece com ela. Acrescentou que possui as chaves da residência, a fim de poder prestar auxílio sempre que necessário. Segundo o depoente, a autora encontra-se, na prática, em condição de acamamento, necessitando de auxílio para sair da cama, tomar banho, vestir-se, deslocar-se até a mesa para se alimentar — tarefa que, em algumas ocasiões, sequer consegue realizar sozinha. Informou que o uso de muletas não lhe traz qualquer benefício, pois sempre precisa da presença de outra pessoa para se locomover. Afirmou que, caso tivesse acompanhamento médico regular, seria muito benéfico para a autora, acrescentando: "a medicina hoje sabe o que faz, né…". Questionado se teria algo mais a declarar, respondeu: "mas olha, tudo que vocês puderem fazer para ajudar a dona Lurdes… necessita de ajuda… e é um ser humano que a gente tem que ajudar". Relatou ainda que a autora perdeu o marido em decorrência de infarto e, atualmente, vive sozinha, visto que seus filhos residem em locais distantes. Em resposta a questionamento da parte ré, negou possuir formação em enfermagem ou área correlata, esclarecendo que procedimentos como colocação de sonda e similares são realizados pelo médico do posto de saúde.*

***Jorge Gilberto Ruver**, arrolado pela autora e ouvido na qualidade de informante, relatou não residir com a autora. Questionado sobre o estado de saúde de sua mãe, afirmou que é bastante delicado. Informou que ela possui 87 anos, é portadora de diabetes, faz uso diário de medicamentos, apresenta hipertensão com variações significativas, assim como na glicemia, e que não se alimenta adequadamente. Relatou que necessita de colocação de sonda gástrica e, quando está com a sonda, fica muito nervosa e tenta retirá-la. Esclareceu que, até por questões financeiras, recebem grande auxílio do posto de saúde, pois, durante o horário de expediente, comparecem ao local e recebem atendimento das enfermeiras. Ressaltou que, apesar de a autora receber dois salários mínimos, as despesas são muito elevadas, especialmente pelo fato de, à noite, terem de pagar uma enfermeira para permanecer na residência. Informou que, em razão de toda a situação, passou a fazer uso de antidepressivos, sentindo-se sobrecarregado por não ter descanso. Declarou que sua mãe sofre muito e questionou até que ponto essa condição pode ser considerada vida. Acrescentou que, sem auxílio, ela não consegue sequer sair da cama e, mesmo quando é retirada, reclama de dores pelo corpo. Relatou que a autora faz uso diário de fraldas, insulina e glifage, e que já foi hospitalizada, mas, nos últimos tempos, isso não tem ocorrido devido à dificuldade de transportá-la, sendo que, em algumas ocasiões, os médicos vão até sua residência para realizar acompanhamento. Relatou que todos os familiares estão esgotados, mas que o problema não é a falta de vontade em ajudar, e sim a ausência de conhecimento técnico para realizar os cuidados necessários. Enfatizou que a autora precisa de atenção especializada, pois eles não conseguem suprir integralmente as demandas. Informou que dois vizinhos auxiliam regularmente nos cuidados. Afirmou que, ao longo da vida, sempre arcou com os custos de enfermeira e outras despesas, e que a presença de um profissional especializado proporcionaria mais dignidade à sua mãe. Ressaltou que, para prolongar a vida da autora com qualidade, seria essencial contar com cuidados especializados. Acrescentou que ela também faz uso de medicamentos para depressão.*

Consoante se extrai dos relatos prestados pelos informantes, a autora se encontra em estado grave de saúde, estando acamada e necessitando por vezes, inclusive, alimentar-se por meio de sonda gástrica.

No caso em análise, a imperatividade do tratamento domiciliar para a autora não se trata de mera conveniência, mas de uma necessidade premente e vital, atestada por laudo médico detalhado, de modo que não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da enfermidade do beneficiário.

Pensar de modo contrário, seria necessário que o Instituto expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento de que necessitava a parte autora, do que não se desincumbiu.

A negativa por falta de previsão nas suas tabelas e resoluções sem justificativa torna a garantia de assistência à saúde uma não-garantia, pois deixa ao arbítrio exclusivo da discricionariedade do administrador definir o que será fornecido. O beneficiado fica em total insegurança, porquanto não tem qualquer ingerência na formulação das escolhas do administrador para a fixação de quais tratamentos serão ofertados.

A negativa só pode ser acolhida quando devidamente fundamentada, pois, assim não sendo, desconsidera a indicação do médico assistente, profissional com melhor capacidade de definir o melhor tratamento para o seu paciente.

Importante aduzir que a autora mantém contrato firmado com o Instituto há mais de 20 anos, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde. Logo, não se mostra razoável a negativa levada a efeito pelo IPE-Saúde.

Nesse sentido, é uníssono o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade do IPE-Saúde restringir cobertura ao tratamento indicado pelo médico que acompanha a enfermidade da parte, pura e simplesmente, em razão da ausência de previsão para cobertura, senão vejamos:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. IPÊ-SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM MATERIAIS NÃO COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. PACIENTE COM FRATURA NA COLUNA E NO QUADRIL, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUADRO COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA URGENTE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO IPERGS. ARTS. 5º E 25 DA LEI Nº 14.634/2014. I) A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde, conforme arts. 1º e 2º da Lei Complementar 12.134/04. II) A indicação do tratamento postulado pelo demandante foi prescrito pelo médico que atendeu a paciente após o acidente de trânsito. É ele quem tem reais condições de indicar o melhor tratamento para seu paciente e de prescrever o material mais adequado, razão pela qual cabível o ressarcimento à parte autora do valor referente ao material utilizado. III) A indenização por danos morais não prescinde de produção de prova, onde deve ser cabalmente demonstrado o abalo sofrido pelo requerente (art. 373, I, do CPC). Na hipótese dos autos, apesar dos transtornos ocorridos, não assiste razão à apelante quando fundamenta ser cabível a indenização pretendida, haja vista não haver nenhuma prova de abalo moral tão intenso que mereça ser indenizado. III) Quanto às custas processuais, considerando que a presente ação foi ajuizada em 01/04/2016, aplicável a Lei Estadual nº 14.634/2014, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais e isentou a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa nos processos ajuizados a partir de 15/06/2015. Orientação do Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ. APELOS DA ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS E APELO DO IPERGS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081894362, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29/08/2019). Grifei.*

Na mesma linha, é o entendimento acerca do tratamento multidisciplinar:

> *PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPE-SAÚDE. TRATAMENTO MUTIDISCIPLINAR. AUTISMO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.145/18, ARTIGOS 1º, 2º, CAPUT, E 4º, §§ 1º E 2º. NEUROPEDIATRIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PROTOCOLOS DA AUTARQUIA E DESATUALIZAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. A melhor compreensão dos dizeres dos artigos 1º, 2º, caput, e art. 4º, §§ 1º e 2º, Lei Complementar Estadual nº 15.145/18, leva a que não se excluam atendimentos indispensáveis à saúde, inclusive quanto aos que não decorram da atuação de médicos, como se dá com fonoaudiologia e terapia ocupacional, observada, no entanto, a coparticipação, uma vez expressamente prevista nos artigos 2º e 30, Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018, não configurando a hipótese quaisquer das exceções previstas na referida legislação. REEMBOLSO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. DESCABIMENTO. Descabido reembolso de despesas relativas a educação especial, método ABA, tratamento não concedido na presente demanda. APELO DO IPE-SAÚDE PROVIDO, EM PARTE, DESPROVIDO O DO AUTOR. (Apelação Cível, Nº 50006207020208210096, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 04/05/2022).*

Com efeito, <u>a escolha do tipo de tratamento de que necessita o paciente cabe ao médico e não ao convênio</u>, pois o médico assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar o melhor tratamento visando o melhor para o paciente.

Há, por fim, que se observar a coparticipação dos usuários do IPE-SAÚDE, inclusive no custeio de tratamentos multidisciplinares:

> *IPE-SAÚDE. TRATAMENTO MUTIDISCIPLINAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.145/18, ARTIGOS 1º, 2º, CAPUT, E 4º, §§ 1º E 2º. NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PROTOCOLOS DO IPERGS E DESATUALIZAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. A melhor compreensão dos dizeres dos artigos 1º, 2º, caput, e art. 4º, §§ 1º e 2º, Lei Complementar Estadual nº 15.145/18, leva a que não se excluam atendimentos indispensáveis à saúde, inclusive quanto aos que não decorram da atuação de médicos, como se dá com a fonoaudiologia e terapia ocupacional, observada, no entanto, a coparticipação. REEMBOLSO. DESCABIMENTO. Descabido reembolso de despesas realizadas já após o ajuizamento da ação, sem que houvesse definição quanto ao pedido de antecipação de tutela, que, após, restou indeferido, inexistindo, ainda, urgência a impossibilitar aguardo de tal definição, aplicando-se o disposto no artigo 35, Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018. RECUSA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Não se pode vislumbrar dano moral de toda e qualquer negativa administrativa, ainda mais quando, em tese, a negativa da autarquia em fornecer o tratamento multidisciplinar pleiteado não pode ser rotulada como carente de fundamentos, ausente, ainda, na hipótese, comprovação de que efetivamente houve prejuízo a ser reparado. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. ART. 5º, I, LEI ESTADUAL nº 14.634/14. Ajuizada a ação já na vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, é a autarquia estadual isenta do pagamento das custas processuais, a teor do art. 5º, I, da legislação referida. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. É de ser afastada a genérica condenação da autarquia estadual ao pagamento de despesas processuais, senso estrito, ausente mínima informação nos autos sobre a sua ocorrência, sob pena de se impor condenação teórica, não se enquadrando em seu conceito gastos com citações e intimações, que, por corresponderem a atos inerentes ao processo, consideram-se como custas (EDiv no REsp nº 464.586/RS, TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª SEÇÃO, STJ). APELOS PROVIDOS, EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70084353507, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 26/08/2020).*

Desse modo, procede o pleito com relação ao fornecimento do tratamento pleiteado pela autora.

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **julgo procedente** o pedido formulados por MARIA LURDES KONRATH RUVER, em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, para **condenar** o réu ao custeio e fornecimento integral do tratamento domiciliar multidiciplinar da autora, de forma contínua, nos termos do laudo médico (evento 1.6), por tempo indeterminado, fornecendo os medicamentos, materiais, equipamentos e profissionais solicitados no laudo médico.

Julgado procedente o pedido, evidenciada a probabilidade do direito, e existente perigo de dano, pelo manifesto risco à integridade física e à própria vida da paciente caso permaneça sem os cuidados médicos adequados, **defiro a tutela de urgência** para determinar ao réu o imediato custeio e fornecimento integral do tratamento domiciliar multidiciplinar da

autora, de forma contínua, nos termos do laudo médico (evento 1.6), por tempo indeterminado, fornecendo os medicamentos, materiais, equipamentos e profissionais solicitados no laudo médico.

Sucumbente, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais vão fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2, do CPC.

Publicação e registro eletrônicos. Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Interposta(s) apelação(ões), intime(m)-se o(s) apelado(s) para contrarrazões, no prazo legal.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do RS, em conformidade com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Ausente a interposição de recurso voluntário e/ou com o trânsito em julgado sem modificações, intime-se a parte autora para que diga sobre o prosseguimento, em dez dias.

Transitado em julgado e recolhidas custas/despesas processuais e/ou cumprido o disposto no Ato n.º 072/2022-P, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **HELENA MACHADO DE ALMEIDA, Juíza de Direito**, em 20/08/2025, às 19:55:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10088911513v45** e o código CRC **3c3ef526**.